

34 - 05-douleurs vasculaires- Pr. L. Bendriss

(0:07 - 0:32)

Bonjour, le cours d'aujourd'hui va être les douleurs d'origine fasculaire, c'est-à-dire artérielles ou veineuses. Les algies fasculaires ou douleurs fasculaires pourraient être bien évidemment artérielles ou veineuses. La localisation la plus fréquente c'est essentiellement les membres inférieurs et par la suite la main.

(0:32 - 1:08)

Alors quand vous avez une atteinte artérielle, c'est toujours dû principalement à l'athérosclérose qu'on avait expliqué. Et donc d'où l'importance de chercher les facteurs de risque cardiovasculaires à terme, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, l'âge, le sexe masculin, la sédentarité et l'obésité. Et puis pour l'atteinte veineuse, est-ce serait-il qu'il y a une obstruction du veine qui va un petit peu gêner le drainage du veineux? Et là on va chercher l'importance des facteurs de risque thromboemboliques veineux, c'est-à-dire qui vont favoriser la spasmie et la formation d'un thrombus au niveau du veine.

(1:11 - 2:07)

Alors on va commencer avec les douleurs vasculaires des membres inférieurs sur le versant artériel, c'est-à-dire artérie des membres inférieurs ou ce qu'on pourrait appeler aussi artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc elles peuvent se manifester cliniquement par ce que l'on appelle claudication intermittente douloureuse, c'est une douleur qui survient à l'effort au niveau du membre inférieur. C'est une manifestation clinique de l'ischémie musculaire à l'effort.

Alors comme on en avait parlé par rapport à l'atteinte coronarienne, il y a toujours une balance et une adéquation entre les apports et les besoins. Alors les muscles des membres inférieurs ont des besoins au repos, mais quand vous marchez, les besoins augmentent, notamment en oxygène et en nutriments. Alors pour ceci, ça doit suivre une vasodilatation artérielle pour pouvoir combler ces besoins.

(2:07 - 2:39)

Quand vous avez un anévrisme, une plaque ou une sténose sur cette artère, ça ne va pas suffire pour satisfaire ces besoins. Donc pourrait apparaître une ischémie qui va se manifester cliniquement par ce qu'on appelle la claudication intermittente. Et sur le plan type de cette douleur, c'est une coulée de temps ou simplement crampes, c'est-à-dire une sorte de contraction très douloureuse au niveau du muscle, qui va apparaître à la marche et qui disparaît à l'arrêt de la marche, c'est-à-dire que c'est un problème d'adéquation entre les apports et les besoins à l'effort.

(2:39 - 3:13)

Et il y a autre chose qu'on voudrait préciser, le patient pourrait vous dire que je commence à ressentir cette douleur à partir de 100 mètres de marche, c'est ce qu'on appelle le périmètre de marche, plus ce périmètre de marche se raccourcit, plus les choses s'aggravent, donc c'est un élément d'évaluation de la gravité de la claudication. Alors, le territoire ou la localisation de la douleur va déborder un petit peu du site d'obstruction artérielle. Plus vous êtes éloigné, le site d'obstruction est éloigné, plus vous allez sentir les muscles qui sont juste en dessous.

(3:14 - 3:34)

C'est-à-dire quand vous avez une fémorale superficielle qui est obstruée, alors la douleur qu'on va sentir c'est au niveau des mollets, des jambes, du muscle du mollet. Et si c'est la fémorale profonde et commune ou iliaque externe, on va sentir la douleur au niveau des muscles de la cuisse. Si c'est l'iliaque interne qui est obstruée, c'est une douleur musculaire au niveau des fessiers.

(3:35 - 4:03)

Et si c'est au niveau, un site d'obstruction au niveau de la honte, carrément, donc ça veut dire que les deux membres inférieurs sont compromis par rapport à leur perfusion, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lericq. Vous avez une obstruction au niveau de la honte juste avant la bifurcation en artère iliaque. Et dans ce syndrome de Lericq, vous avez des douleurs au niveau des membres inférieurs plus une dysfonction érectile parce que vous avez un défaut de vascularisation des organes génitaux par les artères iliaques internes.

(4:08 - 4:38)

Après une certaine évolution dans le temps, quand l'athérose va un petit peu progresser dans le temps, donc les douleurs qui apparaissent à l'effort vont cette fois-ci s'aggraver, apparaître au repos. Ça veut dire que les choses commencent à s'aggraver, ça veut dire que cette perfusion artérielle ne suffit même pas au repos, c'est-à-dire à l'état normal. Donc c'est une douleur de repos qui persiste plusieurs heures ou plusieurs jours, en position allongée, elle cède parfois en position assise contre le passant, se met assise et relève un petit peu ses jambes.

(4:39 - 4:59)

La douleur peut diminuer. Alors ça c'était l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui est une forme chronique de séquelle artérielle. Alors on va passer cette fois-ci à l'autre forme qui est une forme aiguë, qui n'a rien à voir avec l'athérosclérose ou les plaques d'athérome, c'est ce qu'on appelle l'ischémie aiguë.

(4:59 - 5:31)

Alors ça c'est une forme où vous avez des artères saines, vous n'avez pas de plaques d'athérome, vous n'avez pas de sclérose, mais vous avez un embolie qui a migré, par exemple, je ne sais pas, du ventricule gauche, qui va migrer vers la circulation artérielle et obstruer par exemple une artère au niveau des membres inférieurs. Donc c'est un embolie qui vient de migrer et qui va obstruer une artère saine, c'est l'ischémie aiguë. Alors l'ischémie aiguë, sachez que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique parce que vous n'avez pas une progression qui serait dans le temps.

(5:31 - 6:23)

C'est une douleur de repos d'emblée qui est intolérable et insupportable, sans position enthalgique, qui est exacerbée au moindre contact, c'est un membre qui va devenir blanc et froid parce qu'il n'est pas vascularisé et c'est un défaut de vascularisation qui va être soudain, sans avoir eu le temps de mettre une circulation collatérale. Ça va évoluer vers une hypoesthésie du membre jusqu'à une paralysie et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique pour aller ouvrir ou faire ce qu'on appelle l'embolectomie, c'est-à-dire enlever l'embolie pour permettre une perfusion, sinon vous aurez la nécrose de ce membre. Alors pour l'ischémie aiguë, on la caractérise par ce que l'on appelle 4P de Griffith, c'est 4P, pain, douleur, paralysie, paralysie, pâleur, c'est-à-dire un membre froid, et no pulse, c'est-à-dire quand vous prenez le pouls de ce membre, il va être absent.

(6:26 - 6:51)

Alors par rapport à l'arthropathie, oubliant les langues inférieures dont on avait parlé tout à l'heure, qui est chez la forme chronique, il y a une classification de Fontaine et Leriche qui va nous montrer un petit peu le stade d'évolution de la maladie. Vous avez stade 1, c'est un stade infraclinique, il n'y a pas de limitation du passant même s'il marche. Stade 2, c'est la claudication intermittente dont je vous ai expliqué tout à l'heure et qu'on va évaluer sa gravité par le périmètre de marche.

(6:51 - 7:25)

Stade 3, c'est les douleurs de repos, pour l'ischémie permanente, périmètre très réduit, vous aurez des troubles trophiques fréquents, c'est-à-dire une peau sèche, fragile, parce que vous avez un défaut de vascularisation cutanée. Puis stade 4, c'est un stade très évolué, vous aurez l'apparition de lésions de nécrose, c'est-à-dire une mort, c'est-à-dire vous aurez un membre ou une extrémité qui vont être noires, avec perte de substances, on pourrait avoir des ulcères, ce qu'on appelle des pertes de substances. Alors on passe au versant veineux, douleurs vasculaires des membres inférieurs, pathologie veineuse.

(7:25 - 8:10)

Vous avez deux sortes de pathologies, vous avez soit sur le système ou le réseau veineux

profond du membre inférieur qui est le réseau fémoropoplité, et puis on va voir par la suite le réseau veineux superficiel qui est le réseau saphénien, saphénie interne ou saphénie externe. Alors sur le réseau veineux profond, vous avez la thrombose veineuse profonde qui s'intègre dans ce que l'on appelle la maladie thromboembolique veineuse, parce que vous avez un risque élevé d'embolie pulmonaire. Quand vous avez une thrombose au niveau d'une veine, par exemple si je vais me dire poplite ou fémorale, ça va migrer vers le système K, vous savez que le système K va se jeter dans l'oreillette droite, puis le ventre est que droit, et vous aurez la migration des phages de thrombose vers les artères pulmonaires, c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire.

(8:11 - 9:01)

Donc c'est une seule maladie qu'on va nommer maladie thromboembolique veineuse, parce qu'il y a un risque élevé de migration et d'avoir une embolie pulmonaire. Alors la douleur qui se réduit à la thrombose veineuse, c'est une douleur inconstante, spontanée, généralement au niveau du territoire occlu, qui est accentuée par le moindre contact et par l'activité physique, et qui apparaît brutalement. Alors pour que j'aie une thrombose veineuse, je dois avoir des facteurs de risque qui vont prédisposer à ceci, et ces facteurs de risque vont répondre à la physiopathologie qui correspond à la tria de Virchow, vous avez trois éléments qui vont prédisposer à avoir cette maladie, soit vous avez la stase veineuse, donc des facteurs de risque qui vont favoriser la stase veineuse, deuxième élément vous avez l'hypercoagulabilité sanguine, et puis troisième élément c'est lésion veineuse.

(9:01 - 9:49)

Plus vous majorez ces facteurs, plus vous êtes prédisposé à avoir une thrombose veineuse. Alors les facteurs de risque qui vont correspondre à cette tria, donc qui vont faire l'une ou l'un de ces éléments de cette tria, vous avez les facteurs de risque permanents de maladie thromboembolique veineuse, quand vous avez d'office une anomalie de coagulation, quand vous avez une paralysie d'un membre avec un spasme prolongé, antécédents déjà personnels de maladie thromboembolique veineuse, un cancer ou antécédents de cancer qui va prédisposer à une hypercoagulabilité, et une surcharge pondérale avec la stase et l'hypercoagulabilité. Vous avez des facteurs temporaires, c'est-à-dire transitoires mais majeurs, l'immobilisation plâtrée d'un membre, donc un plâtre qui va prédisposer à la stase, l'alignement de plus de trois jours, et une chirurgie récente qui va prédisposer à la stase et l'hypercoagulabilité, et probablement une lésion veineuse.

(9:50 - 11:32)

Les facteurs de risque temporaires mais mineurs, voyage par avion, un bus avec plus de six heures de position assise, la période péri-partum prédispose à ceci, parce que vous avez la stase et l'hypercoagulabilité, puis un traitement hormonal contraceptif, la contraception orale

prédispose aussi à avoir une thrombose veineuse profonde. Alors, sur le versant superficiel veineux, c'est-à-dire le réseau, ça fait neuf, je pourrais avoir un thrombus au niveau des veines superficielles, c'est une douleur vive, on regarde un trajet veineux, soit spontanément, soit après un traumatisme minime, parfois augmenté à la marche, elle pourrait être favorisée par un traumatisme de cette veine, soit une insuffisance veineuse, c'est-à-dire que vous avez une incontinence valvulaire au niveau des veines, puis toujours le traitement par la contraception orale, et notamment les oestrogènes. Alors, comme autre pathologie sur le versant veineux loin des thromboses, vous avez l'insuffisance veineuse chronique, ou la maladie varicose, ce qu'on nomme les varices, c'est une dilatation des veines superficielles qui serait due à l'incontinence valvulaire, parce qu'au niveau des veines superficielles, vous avez des valvules, si elles sont incontinentes, vous aurez du son qui va refluer, et vous aurez comme manifestation clinique, une lourdeur de la jambe, les patients vont vous décrire qu'en sentant que notre jambe est lourde, une pesanteur et une fatigabilité de topographie imprécise, mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle est majorée par la position debout, c'est ce qui caractérise cette insuffisance veineuse superficielle, la chaleur, et elle est atténuée par la marche ou le décubitus, c'est-à-dire quand vous surélevez les jambes, donc vous diminuez la douleur de l'insuffisance veineuse superficielle.

(11:35 - 13:11)

Alors, après les membres inférieurs, on va passer au niveau des douleurs abdominales d'origine vasculaire, donc on va parler du versant surtout artériel, l'ischémie mésentérique chronique, donc c'est l'équivalent un petit peu de ce qu'on avait vu par rapport à l'artéropathie oblitère des membres inférieurs, donc c'est une artéromatose, des plaques d'artérome qui vont cette fois-ci être présentes sur les artères digestives, et grossièrement, vous avez trois grandes artères, vous avez le tronc aortique, vous avez les artères mésentériques supérieures et inférieures, entre ces trois, vous avez beaucoup d'arcades anastomotiques, donc généralement, la manifestation de cette ischémie ne va se faire que si vous avez deux artères sur trois digestives qui seraient stérilisées, et vous aurez comme manifestation clinique, une triade qui va être caractéristique, une douleur à type de croupes, période ombilicale qui va survenir à peu près une demi-heure après le repas post-prandial, parce que vous savez que le repas séduit un petit peu l'effort du système digestif, donc ce qu'on appelle un engorgement mésentérique post-prandial, et puis à cause de cet engorgement, le patient va avoir une crainte de s'alimenter, et puis s'il y a une crainte de s'alimenter, il va m'écrire dans cette triade, et un petit peu caractéristique de l'ischémie mésentérique chronique. Il faut rechercher sur ce terrain des facteurs de risque cardiovasculaire, athéromateux, diabète, hypertension, dyslipidémie, sédentarité, obésité et obésité. Alors comme dernière pathologie sur la honte abdominale, la névrose de la honte abdominale, c'est quoi la névrose? C'est une dilatation qui serait permanente et localisée au niveau d'un segment de la honte.

(13:12 - 13:53)

C'est une pathologie qui est souvent asymptomatique. Quand vous avez des symptômes, ça traduit généralement une complication, donc douleur qui va apparaître va traduire une complication, et vous aurez des fois des symptômes non spécifiques, à titre de troubles digestibles, des douleurs lombaires, quand vous avez une compression de cette anévrise, un petit peu des organes de voisinage, et puis à l'examen abdominale, quand vous allez examiner votre patient, l'anévrise, vous allez le sentir comme une masse, parce qu'elle est grosse, une masse battante, parce qu'elle est pulsative, expansive à chaque systole, qui est non douloureuse, sauf si vous avez des complications, puis elle est médiane ou latéralisée à gauche. Donc voilà brièvement un petit peu les douleurs d'origine vasculaire.

(13:53 - 13:54)

Je vous remercie.